

Tạo hình niệu đạo qua nội soi (TUITMR)

Thông tin cho bệnh nhân · Sửa chữa mô sẹo ở cổ bàng quang không cần rạch da

WARWIKI

Đây là phương pháp sửa chữa vết hẹp do mô sẹo tại cổ bàng quang hoặc chỗ nối giữa bàng quang và niệu đạo sau phẫu thuật tuyến tiền liệt, thực hiện hoàn toàn qua ống nội soi — không cần rạch da. Bác sĩ mở mô sẹo rồi khâu niêm mạc bàng quang lành mạnh che lên, giúp vùng này lành theo dạng mở thay vì tái hẹp.

Về thủ thuật này

Sau phẫu thuật hoặc xạ trị tuyến tiền liệt, mô sẹo có thể hình thành tại **cổ bàng quang** hoặc chỗ nối giữa bàng quang và niệu đạo, gây tắc nghẽn dòng nước tiểu. Chỉ đơn giản cắt mô sẹo thường khiến vết thương lành lại trên nền mô sẹo và tái hẹp.

Kỹ thuật này — **TUITMR** (rạch qua nội soi kết hợp tái sắp xếp niêm mạc theo chiều ngang) — giải quyết vấn đề đó:

- Bác sĩ **cắt mô sẹo** qua ống nội soi để mở thông đường tiểu.
- Sau đó, dùng **dụng cụ khâu chuyên dụng**, niêm mạc bàng quang lành mạnh được kéo qua và khâu phủ lên vết cắt — tương tự vạt che phủ nhưng thực hiện qua niệu đạo.

Kết quả ban đầu khả quan: khoảng **9 trong 10** bệnh nhân duy trì đường tiểu thông sau một lần thủ thuật, và gần như tất cả sau lần thứ hai — với nguy cơ tiểu không kiểm soát rất thấp trong nhóm bệnh nhân đầu tiên được báo cáo.

Có an toàn không?

Thủ thuật thực hiện hoàn toàn qua niệu đạo, tránh được các phẫu thuật robot hoặc mổ mở lớn hơn thường dùng cho vấn đề này. Bằng chứng ban đầu cho thấy nguy cơ tiểu không kiểm soát mới thấp, vốn là biến chứng có thể gặp ở các phương pháp khác. Rủi ro bao gồm chảy máu, nhiễm trùng đường tiết niệu và tái hẹp. Đây là kỹ thuật mới, đòi hỏi chuyên môn cao.

GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ

Cổ bàng quang

Phần hẹp dưới bàng quang nối vào niệu đạo.

Co thắt cổ bàng quang

Mô sẹo siết chặt cổ bàng quang, làm tắc dòng nước tiểu.

Hẹp miệng nối

Mô sẹo tại chỗ nối lại sau phẫu thuật tuyến tiền liệt.

Niệu đạo

Ống dẫn nước tiểu ra ngoài cơ thể.

Niêm mạc (lớp lót)

Lớp lót lành mạnh được kéo phủ lên mô sẹo để giữ thông thoáng.

Ống soi bàng quang

Camera mỏng bác sĩ dùng để thực hiện thủ thuật.

Tiểu không kiểm soát

Rò rỉ nước tiểu — nguy cơ mà kỹ thuật này cố giữ ở mức thấp.

Ống thông

Ống mềm đặt trong niệu đạo một thời gian ngắn trong khi lành.

CÓ ĐAU KHÔNG? Thủ thuật được thực hiện dưới gây mê, nên bạn không cảm thấy gì trong lúc làm. Sau đó, bạn có thể thấy rát nhẹ và nước tiểu hơi hồng trong vài ngày. Ống thông được để lại trong một thời gian ngắn. Hầu hết bệnh nhân về nhà trong ngày hoặc sau một thời gian lưu viện ngắn.

Cách chuẩn bị (Trước thủ thuật)

- Thực hiện dưới **gây mê toàn thân** — tuân thủ mọi hướng dẫn trước phẫu thuật (nhịn ăn, các thuốc cần ngưng, kể cả thuốc chống đông máu).
- Xét nghiệm nước tiểu** kiểm tra nhiễm trùng — phải điều trị xong trước khi làm thủ thuật.
- Chuẩn bị sẵn sàng cho việc **mang ống thông một thời gian ngắn** và nhờ người đưa về nhà.

Hãy báo cho nhóm chăm sóc trước nếu bạn:

- Đang dùng **thuốc chống đông máu** hoặc đang bị nhiễm trùng đường tiết niệu
- Đã từng **phẫu thuật tuyến tiền liệt, xạ trị** hoặc điều trị trước đây ở vùng này

Quá trình thực hiện

- 1 Bạn được gây mê và dùng kháng sinh dự phòng.
- 2 Ống nội soi được đưa đến vị trí mô sẹo, một dây dẫn được đặt vào để đảm bảo an toàn.
- 3 Mô sẹo được nong rộng và cắt để mở thông đường tiểu.
- 4 Dùng dụng cụ khâu qua niệu đạo, niêm mạc bàng quang lành mạnh được kéo qua và khâu phủ lên vết cắt, sau đó đặt ống thông.

Sau thủ thuật

- Bạn về nhà **trong ngày hoặc sau lưu viện ngắn**, mang ống thông trong một thời gian ngắn.
- Rát nhẹ và **nước tiểu hơi hồng** vài ngày là bình thường. Uống nhiều nước giúp cải thiện.
- Tránh nâng vật nặng và rặn** trong vài tuần.
- Nội soi kiểm tra lại (khoảng **4 tháng** sau) xác nhận đường tiểu vẫn thông thoáng.

Hãy gọi cho nhóm chăm sóc nếu bạn có:

- Sốt hoặc ớn lạnh
- Không tiểu được**, đặc biệt sau khi rút ống thông
- Tiểu không kiểm soát mới xuất hiện và nặng
- Chảy máu nhiều, cục máu đông hoặc đau ngày càng tăng

BA ĐIỀU CẦN NHỚ

1. Đây là phương pháp sửa mô sẹo ở cổ bàng quang không cần rạch da — mô sẹo được mở ra và phủ niêm mạc lành để lành theo dạng mổ, nguy cơ tiểu không kiểm soát thấp.
2. Chuẩn bị: tuân thủ hướng dẫn nhịn ăn và dùng thuốc, điều trị dứt điểm nhiễm trùng, sẵn sàng cho ống thông ngắn hạn và nhờ người đưa về nhà.
3. Rát nhẹ và nước tiểu hơi hồng vài ngày là bình thường; nội soi kiểm tra xác nhận kết quả. Gọi ngay nếu sốt, không tiểu được, tiểu không kiểm soát mới hoặc chảy máu nhiều.